

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5078854-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: RONALDO SILVA DE OLIVEIRA

DIREITO À SAÚDE. RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. ABIRATERONA 250 MG. NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024.

5078854-11.2024.4.02.5101

510014908350 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5078854-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: RONALDO SILVA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência interposto pela União Federal em face de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo Substituto da 15ª VF do Rio de Janeiro [evento 31, DESPADEC1], que deferiu tutela provisória de urgência para determinar às rés, em solidariedade, o fornecimento à parte autora do medicamento **ABIRATERONA 250 MG** (120 unidades/mês).

A recorrente argumenta, em síntese, a ausência de pressupostos processuais para a manutenção da tutela provisória de urgência, bem como a irreversibilidade dos efeitos na decisão. Nesse rumo, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, subsidiariamente, postula o direcionamento do cumprimento da tutela ao ESTADO DO RIO DE JANEIRO e ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, que entende competentes para implementar as providências necessárias ao fornecimento do medicamento, nos termos do Tema 793 do STF.

Indeferimento da tutela recursal [evento 3, DESPADEC1].

Sem contrarrazões pelo recorrido, em que pese devidamente intimado.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que indeferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"Inicialmente, recebo o recurso diante da regularidade formal pois, notadamente, se insurge de decisão interlocutória que versa sobre antecipação de tutela, com previsão de admissibilidade no âmbito dos Juizados Especiais Federais - JEFs nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001, exceções à regra de irrecorribilidade das decisões no microsistema dos JEFs.

Noutro giro, desacolho o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, consoante a jurisprudência acerca do disposto no art. 43 da Lei nº 9.099/1995, em conjugação com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001, com destaque para o entendimento assentado pela Turma Nacional de Uniformização - TNU no PEDILEF nº 200335007009769, DJe 8/4/2003, relatoria da Juíza Federal MARIA MAURA MARTINS MORAES TAYER. Compreensão que se mantém hígida, a despeito do tempo decorrido.

Passo à análise da decisão recorrida.

Tem-se que o quadro clínico motivador da demanda foi devidamente analisado e decidido pela instância anterior a partir da documentação anexa nos autos originários, notadamente, o relato médico [evento 1, ATESTMED6] em conjugação com as relevantes considerações do parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico - NAT [evento 29, PARECER1].

Assim, ao passo que relato médico no [evento 1, ATESTMED6] noticia o quadro clínico do agravado, que conta 72 anos de idade e é portador de câncer de próstata, apresentando progressão evolutiva da doença com piora cintilográfica, conforme exames apresentados nos autos do processo de origem, o parecer do NAT [evento 29, PARECER1] corrobora a indicação do fornecimento do medicamento ao demandante.

Portanto, a despeito das razões oferecidas pelo União, de par com a circunstância da solidariedade passiva insita à matéria, elas cedem ante a excepcionalidade do quadro clínico demonstrado [evento 1, ATESTMED6] e evidenciada, o que se apresenta compatível com a solução dada na decisão do juízo anterior.

Ainda no que tange a solidariedade passiva dos entes políticos demandados, a Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, determina que o Estado deve garantir a saúde a todos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de proporcionar tal assistência de forma integral e adequada. Ademais, há de ser destacado o princípio da integralidade, previsto no artigo 7º, inciso II, da Lei de regência, a qual estabelece que a assistência à saúde deve ser proporcionada por um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso e em todos os níveis de complexidade.

Nesta senda, destaca-se que a tese firmada pelo STF no Tema nº 793 não afastou a solidariedade entre os entes públicos. Atribuiu-se, porém, o poder-dever à autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação de fazer concernente à prestação da saúde.

Nesse sentido, com os ajustes necessários, o voto, a seguir ementado, no processo nº 5070041-63.2022.4.02.5101, desta relatoria, julgado por unanimidade na Sessão Virtual de 29/11/2023:

"RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUS. CIRURGIA. NECESSIDADE COMPROVADA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA."

Nesse cenário, em juízo de prelibação, a decisão impugnada apresenta-se, além de seu conteúdo fático-probante próprio, em conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça - CNJ relativamente às questões de Direito da Saúde, e com múltiplos julgados desta 6ª Turma Recursal em situações análogas e reiteradas, consoante se extrai, v.g., dos Enunciados a seguir reproduzidos:

Enunciado nº 18. "Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente." (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

Enunciado nº 19. "As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)"

*Nessas condições, **indefiro** o pleito de atribuição de efeito suspensivo".*

Merece confirmação a decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal e, no mérito, merece desprovimento o recurso, para manter a decisão recorrida.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.

5078854-11.2024.4.02.5101

510014908349 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5078854-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência interposto pela União Federal em face de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo Substituto da 15ª VF do Rio de Janeiro [evento 31, DESPADEC1], que deferiu tutela provisória de urgência para determinar às rés, em solidariedade, o fornecimento à parte autora do medicamento **ABIRATERONA 250 MG** (120 unidades/mês).

A recorrente argumenta, em síntese, a ausência de pressupostos processuais para a manutenção da tutela provisória de urgência, bem como a irreversibilidade dos efeitos na decisão. Nesse rumo, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, subsidiariamente, postula o direcionamento do cumprimento da tutela ao ESTADO DO RIO DE JANEIRO e ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, que entende competentes para implementar as providências necessárias ao fornecimento do medicamento, nos termos do Tema 793 do STF.

Indeferimento da tutela recursal [evento 3, DESPADEC1].

Sem contrarrazões pelo recorrido, em que pese devidamente intimado.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que indeferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"Inicialmente, recebo o recurso diante da regularidade formal pois, notadamente, se insurge de decisão interlocutória que versa sobre antecipação de tutela, com previsão de admissibilidade no âmbito dos Juizados Especiais Federais - JEFs nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001, exceções à regra de irrecorribilidade das decisões no microsistema dos JEFs.

Noutro giro, desacolho o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, consoante a jurisprudência acerca do disposto no art. 43 da Lei nº 9.099/1995, em conjugação com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001, com destaque para o entendimento assentado pela Turma Nacional de Uniformização - TNU no PEDILEF nº 200335007009769, DJe 8/4/2003, relatoria da Juíza Federal MARIA MAURA MARTINS MORAES TAYER. Compreensão que se mantém hígida, a despeito do tempo decorrido.

Passo à análise da decisão recorrida.

Tem-se que o quadro clínico motivador da demanda foi devidamente analisado e decidido pela instância anterior a partir da documentação anexa nos autos originários, notadamente, o relato médico [evento 1, ATESTMED6] em conjugação com as relevantes considerações do parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico - NAT [evento 29, PARECER1].

Assim, ao passo que relato médico no [evento 1, ATESTMED6] noticia o quadro clínico do agravado, que conta 72 anos de idade e é portador de câncer de próstata, apresentando progressão evolutiva da doença com piora cintilográfica, conforme exames apresentados nos autos do processo de origem, o parecer do NAT [evento 29, PARECER1] corrobora a indicação do fornecimento do medicamento ao demandante.

Portanto, a despeito das razões oferecidas pelo União, de par com a circunstância da solidariedade passiva ínsita à matéria, elas cedem ante a excepcionalidade do quadro clínico demonstrado [evento 1, ATESTMED6] e evidenciada, o que se apresenta compatível com a solução dada na decisão do juízo anterior.

Ainda no que tange a solidariedade passiva dos entes políticos demandados, a Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, determina que o Estado deve garantir a saúde a todos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de proporcionar tal assistência de forma integral e adequada. Ademais, há de ser destacado o princípio da integralidade, previsto no artigo 7º, inciso II, da Lei de regência, a qual estabelece que a assistência à saúde deve ser proporcionada por um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso e em todos os níveis de complexidade.

Nesta senda, destaca-se que a tese firmada pelo STF no Tema nº 793 não afastou a solidariedade entre os entes públicos. Atribuiu-se, porém, o poder-dever à autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação de fazer concernente à prestação da saúde.

Nesse sentido, com os ajustes necessários, o voto, a seguir ementado, no processo nº 5070041-63.2022.4.02.5101, desta relatoria, julgado por unanimidade na Sessão Virtual de 29/11/2023:

Nesse cenário, em juízo de prelibação, a decisão impugnada apresenta-se, além de seu conteúdo fático-probante próprio, em conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça - CNJ relativamente às questões de Direito da Saúde, e com múltiplos julgados desta 6ª Turma Recursal em situações análogas e reiteradas, consoante se extrai, v.g., dos Enunciados a seguir reproduzidos:

Enunciado nº 18. "Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente." (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

Enunciado nº 19. "As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)"

*Nessas condições, **indefiro** o pleito de atribuição de efeito suspensivo".*

Merece confirmação a decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal e, no mérito, merece desprovimento o recurso, para manter a decisão recorrida.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.